

INFARCTUS DE MYOCARDE

1. SYMPTOMATIQUE

➤ PAS GRAVE

- ✓ VVP G5%
- ✓ TNT : 1mg/H si PAS > 10.
- ✓ Si IDM inférieur : pas de TNT, remplissage prudent.

➤ COMPLICATIONS PRECOCES

- ✓ Désaturation : O2 au masque ou nasal.
- ✓ Syndrome vagal (souvent dans l'IDM inférieur) :
bradycardie, hypo TA, sueurs, pâleur, nausées,
vomissements : ➔ Atropine : 0.5 à 1mg IVD, remplissage prudent.
- ✓ ESV, TV : Xylocaïne : 1mg/kg IVD puis 1mg/kg/H.
- ✓ FV : CEE
- ✓ OAP, choc cardiogénique.

2. ASSOCIE

- ✓ Aspégic 250 à 500mg IVD ou per os.
- ✓ Héparine : 5000 UI IVD.
- ✓ Si douleur persistante : Morphine 2 à 4mg IVD répétés/5minutes si besoin (dose totale < 0.2mg/kg) ou Fentanyl 50 ou 100mcg IVD, sous contrôle de la SpO2.
- ✓ Thrombolyse.

➔ NB : attention à la PA si TNT sub-linguale déjà faite avant l'arrivée au service des urgences.

EMBOLIE PULMONAIRE

1) SYMPTOMATIQUE

✓ GRAVE

- ✓ Remplissage vasculaire.
- ✓ Collapsus persistant malgré remplissage : Dobutamine (5-15 mcg/kg/min) en IVSE.
- ✓ Troubles de conscience : sédation, intubation + ventilation contrôlée.
- ✓ Thrombolyse.

✓ PAS GRAVE

- ✓ VVP (NaCl 0.9 % ou Ringer Lactate).
- ✓ Si nombreux facteurs de suspicion diagnostique et pas de CI aux anti-coagulants : prélever des tubes pour crase et NFS puis Héparine 80 UI/kg IVD puis 400 à 500 UI/kg/ jour en IVSE.

2) ASSOCIE

- ✓ O2 selon SpO2 .

CAT DEVANT COMA NON TRAUMATIQUE

1. LVA : enlever CE, OC, intubation.
2. Etat hémodynamique : remplissage + Drogues vaso-actives.
3. Valium, Gardéнал ; si convulsion,
4. Eliminer une hypoglycémie => Dextro .
5. Chercher une étiologie :

Coma neurologique :

HTA, méningite, abcès cérébrale , AVC, hémorragie méningée. →

TDM, PL

Coma endocrino-métabolique :

Hypoglycémie, IHC, Na+, Ca++, acidose métabolique, coma hyperosmolaire, insuffisance rénale, hypothyroïdie, insuffisance antéhypophysaire, insuffisance surrénale .

Coma toxique :

- Médicamenteuse : BZD, ADT, Neuroleptique, Digitalique, Barbiturique.
- Autre : alpha- chloranose, organo phosphoré.

CAT DEVANT UNE ENCEPHALOPATHIE HEPATIQUE

1. **Surveillance** : TA, T°, FR, Pouls, état de conscience, diurèse, Dextro, Labstix, hémorragie(hématémèse, moelena) .
2. **O2** : si état respiratoire nécessite.
3. **V V, G 10 %** 500 cc + 2g Nacl+ 1g Kcl (hpoglycémie).
4. **ATB** selon la porte d'entrée (hémoculture / ECBU / ascite / radio thorax). Les germes les plus rencontrés sont ; BGN, cocci gram(+) et anaérobie. Rocéphine 1g/ 12H, Genta dans 100cc de SS à passer en 1/2H, Flagyl 1g/24H en perf.
5. **Lactulose** : 2C à S/ 06 H
6. **TP** si < 50 → PFC ou vit K 1amp/J en IVD
7. Si hémorragie digestive haute : sonde Blakmore, sclérothérapie, les anti- H2 sont CI chez le cirrhotiques car sont métabolisés au niveau du foie, on utilise les **protecteurs gastriques** = sucralfate

CAT DEVANT AVC ISCHEMIQUE

1. **V V , S.Salé** à 0.9% 500cc/6H
2. **O2** : 4l /min
3. **Nootropyl** : 1amp*3/ J
4. **Anticoagulant prophylactique** (si pas d'hémorragie).
5. **Surveillance de l'état hémodynamique** : pour garder une meilleure perfusion cérébrale.

➔ hypo TA à 11 : remplissage par SS 0.9 %

➔ HTA à 26/13 : loxen 0.5mg/H

6. **Interrogatoire** : diabète, HTA, tabagisme, hyperlipidémie.
7. **Ex. à demander** : Dextro, Labstix/4H, TDM cérébrale, echo doppler cervical, echo- cœur, ECG, bilan lipidique. HC si $T^{\circ} < 36.6$ ou > 38
8. **Surveillance** : TA, P, T° , FR, FC, Diurèse, état de conscience,

ASTHME AIGUE GRAVE

1. O2 : 6L/min

2. Nébulisation de 2 mimétique :

- Adrénaline ou ventoline + 3cc de SS/15min à maintenir pdt 1H si amélioration toute les 4H.
- Si non SAP : 0.5mg/H jusqu'à 8mg/H
- Si non amélioration : intubation sous sédation : HYPNOVEL 5-10mg ou CURARE amp 4mg

3. Corticothérapie

- Méthyl prednisolone : solumedrol 1 à 6mg/kg en 3*/J (1amp 120mg) (tropisme pulmonaire, pas d'effet minéralocorticoïde)
- HSDC : amp 100mg/6H en IVD

4. Traiter la cause de décompensation : infection, stress, voyage, changement de climat, humidité.

5. Ordonnance

Ventoline spray +clénil fort + cortancyl + hygiène de vie.

ACIDOCETOSE DIABETIQUE

1. **REHYDRATAION** : 1 à 2L de SS en flash+ perfusion de base (4 à 6L/J)

2. **INSULINE ORDINAIRE** :

- Si $> 2.5 \rightarrow$ 10 UI d' I O en I V D/ H (voie I V est utilisée tant que l'acétone persiste)
- Si glycémie capillaire entre 1.8 et 2.5 $\rightarrow$ 10 UI en S/C toute les 4H
- Si glycémie capillaire entre 1.3 et 1.8 $\rightarrow$ 5UI en S/C toute les 4H
- Si glycémie capillaire entre 0.9 et 1.3 $\rightarrow$ rien
- Si inférieur à 0.7 – 0.8 $\rightarrow$ S G 30% en flash

3. **LA CAUSE** :

Chercher et traiter la cause de décompensation ; infection, stress...

ETAT DE MAL EPILEPTIQUE

1. Assurer un bon état respiratoire

2. Assurer un bon état hémodynamique

3. Arrêter les convulsions :

10mg de Diazepam si persiste ; 10mg/kg de Gardéнал dans 200cc de SS à passer en 10 à 15 min puis dose d'entretien 5mg/kg ampoule 40mg.
si persiste ; intuber NESDONAL (THIOPANTAL) 1mg/kg/H.

4. chercher et traiter la cause :

infection, pb métabolique, maladie de système, toxique, méningite,
traumatisme cérébral, arrêt du traitement chez épileptique.

CRISE D' ASTHME CHEZ L'ENFANT

- 1) VV, S Salé : 80cc/kg/j → $D = V/3 * \text{nbre d' H}$
- 2) Nébulisation à la ventoline *3/20min ; 0.01 à 0.03ml/kg/nébul.
+3.5cc de S. Salé =4cc à passer dans 6l/min d' O2 à 20min d' []
puis toute les 6 H.
- 3) HSHC = 5mg/kg/4H
- 4) Opticilline = 100mg/kg/j en IV
- 5) Paracétamol = 15mg/kg/6 H

DESHYDRATATION AIGUE (cas clinique)

Cas clinique :

Nourrisson de 10mois, présente diarrhée, tableau de DHA sévère. P = 6kg

CAT :

- 1) Hospitalisation.
- 2) VVP
- 3) Macromolécules : 15mg/Kg/20 minutes
- 4) Sérum salé 0.9% : 30cc/Kg/H (à la première heure).
- 5) G5% : 70cc/Kg/5heures.+NaCl 3g/L, pas de K+ en attendant la 1^{ère} diurèse .
- 6) Repos digestif.
- 7) Traitement étiologique.
- 8) Prise en charge des complications (convulsion, hypo ou hyper Na+).

NB : débit de perfusion(nombre de gouttes/minute)= volume à perfuser/3*nombre d'heures.

Ex. = V=180cc, nombre d'heures= 1heure. Débit = $180/3*1=60$ gouttes/minute

CONVULSION FEBRILE DE L'ENFANT

- 1) **SURVEILLANCE** : conscience, signes neurologiques
- 2) **VALIUM** : 0.5mg/kg en IR
- 3) **GARDENAL** : 10 à 15 mg/kg dans 50cc de G 5% à passer en 30 minutes.
- 4) **BI – ATB**
 - **TRIAZONE** : 100mg/kg/j (en 2 prises)
 - **GENTA** : 3mg/kg /j en IVD
- 5) **ASPEGIC** : 20mg/kg/prise. (dose de charge).

R.A.A

1) **EXTECILLINE**/ 600.000 UI en IM

2) **PENI – A** : 50mg/kg/j

3) **CORTANCYL** 20mg : 1 à 2mg/kg/j

4) **TRAITEMENT ADJUVANT :**

- **RSS**
- **CALCIUM SIROP** ; 1càc*2/j
- **POTASSIUM SIROP** ; 1càc*2/j
- **GASTROGEL** ; 1càc*3/j
- **STEROXYL** ; 4 gouttes/j

LARYNGITE AIGUE DE L'ENFANT

1) NEBULISATION

1 Ampoule d'ADRENALINE = 1cc

+

½ Ampoule d' HSHC = 1cc

+

S. Salé = 2cc

=> les 4cc de S.Salé + ADRENALINE + HSHC à passer dans 6L/min d'O₂. faire 3 nébulisations de 20min d'[].

2) HSHC : 5mg/kg/j

3) ORD :

- Péni-A + acide clavulanique
- Paracétamol
- CELESTENE
- COQUELUSEDAL

CRISE DE GLAUCOME AIGUE

- 1) **Manitol en flash**
- 2) **Diamox 250 mg /cp : 1cp x 3/jour**
- 3) **Pilocarpine 2% goutte : 1goutte x 3/jour**
- 4) **Cartéol : 1goutte x 2/jour**
- 5) **Prednisolone20 mg : 1mg/kg/jour**
- 6) **Avis ophtalmologie : pour complément de prise en charge.**

FAUSSE COUCHE

1) Devant : R.D.R + métrorragie(sang **rouge**) + douleur pelvienne **médiane**.

2) Prendre : T.A, Pouls, T°.

3) Examen du col.

4) F.C confirmée. Faire :

- V.V
- G 5% + 10 Unités de synto.
- Péni – A + Genta(si T°).
- Curetage évacuateur.

5) **Ordonnance**

- Péni- A 1g : 1cp*2/j
- Méthergin : 20 gouttes*3/j
- Néogynon : 1cp/j
- Tibéral 500mg : 1cp*2/j

O.A.P hémodynamique

- 1) VVP G 5% 250cc.
- 2) O2 – thérapie.
- 3) Position assise, jambes pendantes.
- 4) Furosémide : 1mg/kg.
- 5) H.T.A :
 - Si systolique pure : VD veineux [natispray 400mcg sublingual ou lénital IVSE : 0.5mg/H au début].
 - Systolo – diastolique (P.A > 20% de sa valeur habituelle),
VD artériel [loxen IV : 1 à 2mg/H au début sauf si R.A ou R.M connus ou suspectés.
- 6) I.D.M : thrombolyse.
- 7) I.R.C : dialyse.

CHOC ANAPHYLACTIQUE

1. VVP
2. Remplissage par macromolécule (cristaloïde).
3. Adrénaline IV : 1mg dans 10ml de Nacl 0.9% ==> 0.1mg/min jusqu'à des signes cliniques.
4. Eviction de l'allergène (arrêt perfusion ou transfusion).
5. O2.
6. D.D, jambes surélevées si absence de dyspnée. Sinon , position en hamac (demi- assis, jambes surélevées).
7. Si bronchospasme : nébulisation de ventoline 5mg ou adrénaline 2mg dans 3cc de S.salé avec O2 (6-8l/min).
8. Corticoïde : solumédrol 1mg/kg IVD ou H.S.H.C : 200-400mg IVD.
9. Si choc peu sévère : anti-histaminique : atarax.

ORGANO PHOSPHORES

1. **DIAGNOSTIC (+)** : signes digestifs+ sd central+ sd muscarinique+ sd nicotinique.

2. **ELIMINATION DU TOXIQUE :**

- Soustraire la victime à l'atmosphère toxique.
- Si pénétration cutanée : déshabiller et laver à grand eau pendant 15minutes.
- Si projection oculaire : laver abondamment et suffisamment longtemps.
- Si ingestion O P : lavage gastrique.

3. **SYMPTOMATIQUE :**

- Intubation et ventilation si DR.
- Atropine : 2mg [1 à 4] IVD, toutes les 5 à 10 minutes ==> tachycardie, peau rouge et sèche.

4. **ANTIDOTE :** PRALIDOXIME ; CONTRATHION 200 à 400mg chez l'adulte sont dilués dans S.Salé et passés en 30minutes.

5. **Déconseillés :** ADRENALINE / THEOPHYLINE/
PHENOTHIAZINES/ BARBITURIQUE/ MORPHINE/ CURARE
DEPOLARISANTS.

INTOXICATION AUX BARBITURIQUES

1. ELIMINATION DU TOXIQUE

- **LAVAGE GASTRIQUE.**
- **CHARBON ACTIVE** : 40 à 50g au début, puis 20 à 25g/6H.
- **Epuration rénale** = diurèse osmolaire alcaline [G 10%, mannitol 10% et Bicarbonate 14%] à raison de 6 à 8L/Jour.
- **Epuration extra- rénale** : dialyse.

2. SYMPTOMATIQUE

- Intubation et ventilation artificielle en cas de coma avec troubles respiratoires.
- Remplissage vasculaire si collapsus.
- Réchauffement si hypothermie.
- Traiter éventuelle infection.
- Nursing si hospitalisation au long cours.

INTOXICATION AUX ANTIDEPRESSEURS

TRICYCLIQUES

1. DIAGNOSTIC (+)

- a. **Syndrome neurologique** = coma vigil, contractures musculaires (masséters), signes pyramidaux, convulsions.
- b. **Syndrome atropinique** = mydriase, sécheresse buccale, paresse vésicale, ralentissement du transit qui favorise l'absorption par stagnation, tachycardie.
- c. **Syndrome cardio-vasculaire** = BAV du 1er degré, QRS large, allongement de QT, onde T aplatie, parfois arrêt cardio respiratoire.

2. ELIMINATION DU TOXIQUE

- Lavage gastrique.
- Charbon activé.
- Epuration rénale : peu d'intérêt.

3. SYMPTOMATIQUE

- Si coma + TR ==> intubation + ventilation artificielle.
- Collapsus ==> remplissage vasculaire.
- Traiter les crises convulsives.
- Trouble de conduction = > Bicarbonate de Na+ si QRS > 10 msec.

SYNDROME NEPHROTIQUE(à propos d'un cas)

Cas clinique :

Fille âgée de 27 mois, ATCD= 0. P= 14kg, qui présente depuis six (6) jours oedèmes des paupières+ ballonnement abdominale(ascite) + OMI.

Labstix : protéine +++, sang 00.

Bilan : ASLO : 34 UI. F(x) rénale : 0.16 urée, 3.3 mg/L créatinine.

Protidémie= 47g/L

==> SYNDROME NEPHROTIQUE .

CAT:

1. **Hospitalisation.**
2. **Cortancyl 20 mg : 1cp1/2 par jour pendant 1mois.**
3. **Traitement adjuvant :**
 - RSS
 - Potassium sirop : 1/2 c à c* 3/J
 - Calcium sirop : 1/2 c à c *3/J
 - Sterogyl ampoule
 - Gastrogel sirop.

PARAPHENYLENE DIAMINE

1. ELIMINATION DU TOXIQUE

En cas de pénétration cutanée : déshabiller et laver à grande eau pendant une durée suffisante [15minutes].

En cas de projection oculaire : laver abondamment et suffisamment longtemps.

En cas d'ingestion : lavage gastrique.

2. DETRESSE RESPIRATOIRE

Intubation et ventilation, parfois recours à la trachéotomie de sauvetage.
Traitement de l'œdème : HSHC 100mg/04Heures.

3. COMPLICATIONS

Réanimation volémique : association sérum salé, bicarbonate 14% et sérum glucosé sur la base de 10 à 12L/jour. Objectif : diurèse >200ml/Heure et pH urinaire >6.5.

Prévention de l'IRA myoglobulinurique : réanimation hydroélectrolytique + diurétiques de l'anse [furosémide 100mg/4 à 6 heures].

Hyperkaliémie : hyperdiurèse alcaline forcée, parfois hémodialyse en urgence.

Hypocalcémie : à ne pas corriger.

hyperphosphorémie initiale : ne requiert pas de traitement spécifique.

PHOSPHURE D'ALUMINIUM

I. AGIR SUR L'HYDROGENE PHOSPHORE

1. REDUCTION DE L'ABSORPTION

- Lavage gastrique au permanganate de potassium à 1/10000.
- Charbon activé.
- Anti-acides.
- Huile de paraffine.

2. DETOXIFICATION

- Prévention de la toxicité organique par : sulfate de magnésium IVD à la dose de 1g puis 1g/H toutes les 03Heures , puis 1g toutes les 06 heures.

3. ACCELERATION DE L'EXCRETION

- Hyperhydratation +/- furosémide [40 à 60mg].
- Hémodialyse.

II. SYMPTOMATIQUE

25/49



- Si DR : intubation et ventilation artificielle.
- Si état de choc : remplissage vasculaire +/- vasopresseurs.
- Troubles de rythme : Xylocaïne 1mg/kg.
- Troubles de conduction : atropine 1 à 4mg voire entraînement électrosystolique.
- Bicarbonates si acidose profonde.
- Correction de l'hypoglycémie et de l'insuffisance rénale aigue.

PHOSPHURE D'ALUMINIUM

I. AGIR SUR L'HYDROGENE PHOSPHORE

1. REDUCTION DE L'ABSORPTION

- Lavage gastrique au permanganate de potassium à 1/10000.
- Charbon activé.
- Anti-acides.
- Huile de paraffine.

2. DETOXIFICATION

- Prévention de la toxicité organique par : sulfate de magnésium IVD à la dose de 1g puis 1g/H toutes les 03Heures , puis 1g toutes les 06 heures.

3. ACCELERATION DE L'EXCRETION

- Hyperhydratation +/- furosémide [40 à 60mg].
- Hémodialyse.

II. SYMPTOMATIQUE

- Si **DR** : intubation et ventilation artificielle.
- Si **état de choc** : remplissage vasculaire +/- vasopresseurs.
- **Troubles de rythme** : Xylocaïne 1mg/kg.
- **Troubles de conduction** : atropine 1 à 4mg voire entraînement électrosystolique.
- Bicarbonates si **acidose profonde**.
- Correction de **l'hypoglycémie et de l'insuffisance rénale aigue**.

ANTIDOTES

<u>ANTIDOTE</u>	<u>INTOXICATION</u>	<u>INDICATION</u>
Atropine	Anticholinestérasique	Syndrome muscarinique
flumazénil	Benzodiazépines pures	coma
Pralidoxime	Organo-phosphorés	Signes nicotiniques
Naloxone	opiacés	Détresse respiratoire
Fragment Fab	digitaliques	K+, troubles de rythme, trouble de la conduction.
Lactates de sodium molaire	Antidépresseurs tricycliques	QRS large, collapsus cardiovasculaire.
Bleu de méthylène	Agents méthémoglobinisants	cyanose
Glucagon, cathécolamines	Béta-bloquants	Collapsus, bradycardie avec BAV
propranolol	trichloréthylène	Hyperexcitabilité ventriculaire.
Vitamine B6	Hydrazine et ses dérivés	convulsions
hydroxocobalamine	Intoxication cyanhydrique	Acidose métabolique , collapsus.
Sels de calcium	Oxalates et fluores	Hypo calcémie.
oxygène	cyanure	Acidose métabolique, collapsus, coma
oxygène	Monoxyde de carbone	Manifestations neurologiques et cardiaques.
vitamineK	AVK	saignement
N -acétylcystéine	paracétamol	Toxicité hépatique
Ethanol	Méthanol-Ethylène glycol	coma